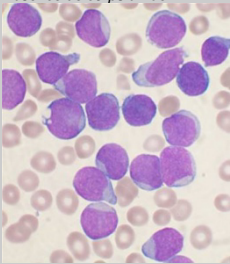
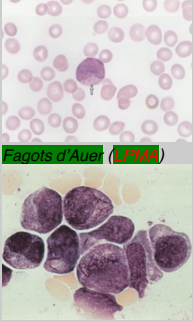
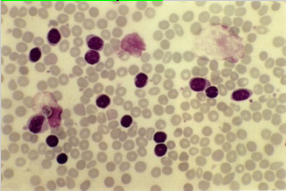


Caractéristique	LLA	LMA	LLC	LMC
Définition	Lymphoblastes immatures	Myéloblastes immatures	Accumulation de lymphocytes B matures qui sont dysfonctionnels	Cellules myéloïdes (précurseurs Leucocytes et Thrombocytes)
Âge le plus fréquent	Enfants et jeunes adultes	Adultes	Adultes âgés (> 60 ans)	Adultes (40-50 ans)
Début	Rapide (jours à semaines)	Rapide (jours à semaines)	Insidieux Asymptomatique pdt des années	Insidieux (svt asymptomatique) Évolue en <i>trois phases</i> : chronique, accélérée et blastique
Symptômes principaux	Fatigue Fièvre (svt le 1 ^{er} symptôme) Infections fréquentes Douleurs osseuses Lymphadénopathie indolore Hémorragies Sueurs nocturnes Perte de poids SNC : méningite leucémique Obstruction des voies respiratoires (LLA-T) Syndrome de la VCS Leucostase : SNC, Testicules	Fatigue Infections fréquentes Hémorragies (purpura, pétéchies) Pâleur Douleurs osseuses Leucémie cutanée Hyperplasie gingivale (sous-types M4 et M5) Leucostase	Fatigue Infections fréquentes Sueurs nocturnes Perte de poids	Fatigue Perte de poids Sueurs nocturnes Leucostase : Infarctus splénique et myocardique Occlusion des vaisseaux rétiens Priapisme leucémique Progression rapide vers la crise blastique
Hépatosplénomégalie	Hépatosplénomégalie	Rare	Hépatomégalie et/ou splénomégalie	Splénomégalie (chez 75%) Leucocytose / Pléocytose extrême
Frottis sanguin	Anémie Neutropénie Thrombocytopénie Blastes > 20% dans le sang : Lymphoblaste >20% Petites à moyennes tailles Noyaux irréguliers Nucléoles peu apparents Granules grossiers Absence de corps d'Auer 	Anémie Neutropénie Thrombocytopénie Blastes > 20% dans le sang Myélophoblaste >20% Grandes tailles Noyaux ronds ou en forme de rein Nucléoles proéminents Granules fins Bâtonnet d'Auer (positif MPO)  Fagots d'Auer (LPM4)	Anémie Neutropénie Thrombocytopénie Lymphocytose > 5 G/L persistante Lymphocytes matures Ombres de Gumprecht 	Cellules progénitrices intermédiaires (myélocytes, métamyélocytes) Basophilie, éosinophilie Faible phosphatase alcaline leucocytaire (PAL) Présence de cellules blastiques dans le sang indique transition vers la phase accélérée (AP-CML) et la crise blastique (BP-CML)
Immunophénotype	MPO négatif TdT positif PAS souvent positif LLA-B : CD10, CD19, CD20 LLA-T : CD2-CD8, cCD3	MPO positif TdT négatif PAS négatif CD13, CD33, CD34, CD117 HLA-DR	CD5, CD19, CD20 (dim), CD23, CD43 Restriction des chaînes légères (kappa ou lambda)	
Cytogénétique	Adulte : t(9;22) Translocation de Philadelphie Enfant LLA-B : t(12;21), Trisomie 4, 10 pré-LLA-B : Hyperdiploïdie	t(15;17) PML-RARα (LPM3) Anomalies génétiques récurrentes (t(8;21), inv(16), ou t(16;16))	FISH pour aberrations chromosomiques courantes : del(17p), del(11q), trisomie 12, del(13q)	Caryotype conventionnel FISH pour confirmation du Gène de fusion BCR-ABL1 (Chromosome de Philadelphie)
Marqueurs pronostiques	Hyperdiploïdie Translocations spécifiques : t(9;22) (BCR-ABL / tr. de Philadelphie) : Mauvais pronostic	FLT3-ITD Anomalies cytogénétiques récurrentes	IGHV muté del(13q) isolé (bon pronostic) del(17p), del(11q) TP53 muté β2-microglobuline élevée LDH élevé (bon pronostic)	Caryotype conventionnel FISH pour confirmation du gène de fusion BCR-ABL1
Traitement initial	Hydroxyurée si tr.Philadelphie Chimiothérapie intensive +/- suivie de greffe de moelle osseuse	ATRA-ATO (LPM4) Chimiothérapie intensive + suivie de greffe de moelle osseuse	Observation si asymptomatique Immunothérapie TKI Chimiothérapie	Inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) (imatinib) +/- suivis de greffe de moelle osseuse en cas de progression
Pronostic	Enfants : Bon (85-90% de survie) Adultes : Moins favorable	Variable : Dépend de l'âge et des comorbidités (30-40% de survie à 5 ans)	Généralement bon, mais dépend de l'âge et des comorbidités	Bon avec le traitement (90% de survie à 5 ans) Moins favorable en phase avancée